

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT OTAK JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG BAGI PASIEN JAMINAN

Nomor : 238/U000000/2025-S0
Nomor : HK.03.01/D.XIX/4727 2025

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-03-2025)** bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya QQ PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0253039.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts-0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, Sp.An-KIC, KAKV** selaku Direktur Utama karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo** sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Kesehatan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tanggal 15 Mei 2023, yang karena bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing disebut “**Pihak**” dan secara bersama – sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur sebagai kuasa penuh sebuah rumah sakit yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang merupakan rumah sakit milik dibawah naungan BUMN yang berkedudukan di Kota Makassar;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Utama kuasa penuh sebuah rumah sakit pemerintah yang telah terakreditasi dan bergerak dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal rujukan parsial untuk pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan radioterapi, angiografi koroner, endoscopy, HIV/AIDS dan TB) bagi pasien jaminan (BPJS atau jaminan perusahaan lainnya) dan pelayanan luka bakar yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Bahwa rujukan parsial ini dilakukan karena alasan tidak tersedianya alat dan atau bahan pemeriksaan penunjang pada **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** adalah sebuah Rumah Sakit dibawah naungan BUMN yang berkedudukan di Kota Makassar berstatus Badan Layanan Otak dan Jantung di bawah naungan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar** yang selanjutnya dapat disingkat dengan RSWS adalah sebuah rumah sakit milik Pemerintah yang telah terakreditasi dan bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. **Pemeriksaan Penunjang** adalah suatu pemeriksaan medis lanjutan setelah pemeriksaan fisik pada penderita yang dilakukan atas indikasi tertentu yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas.
4. **Pemeriksaan laboratorium** adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urine (air kencing), darah, sputum (dahak), dan sebagainya untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan Patologi Klinik, pemeriksaan Patologi Anatomi dan pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi.
5. **Pemeriksaan Patologi Klinik** adalah suatu tindakan atau prosedur pemeriksaan yang melakukan diagnosis berdasarkan pemeriksaan morfologis, mikroskopis, kimia, mikrobiologis, serologis, hematologis, imunologis, parasitologis dan lain-lain.
6. **Pemeriksaan Patologi Anatomi** adalah suatu tindakan atau prosedur pemeriksaan yang melakukan diagnosis berdasarkan pada pemeriksaan kasar, mikroskopik dan molekuler atas organ, jaringan dan sel.
7. **Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi** adalah suatu tindakan atau prosedur pemeriksaan yang melakukan diagnosis berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel darah, urin, feses, serta sekret dan kerokan kulit yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis, pengecatan maupun pembiakan.
8. **Pemeriksaan Radiologi** adalah pemeriksaan dengan menggunakan teknologi pencitraan untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit. Pemeriksaan radiologi berguna untuk membantu dokter melihat kondisi bagian dalam tubuh. Pemeriksaan Radiologi terdiri dari 2 (dua) yaitu pemeriksaan Radiodiagnostik dan Radioterapi.
9. **Pemeriksaan Radioterapi** atau disebut juga **terapi radiasi** adalah pemeriksaan medis yang digunakan untuk menangani penyakit kanker. Prosedur ini dilakukan dengan bantuan energi sinar-X yang kuat untuk membunuh sekaligus menghentikan perkembangbiakan dan penyebaran sel-sel kanker yang bersarang di dalam tubuh.
10. **Pemeriksaan Angiografi Koroner** adalah pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengamati pembuluh darah jantung dengan menggunakan teknologi pencitraan Sinar-X. Prosedur ini dilakukan terutama untuk mengamati bagaimana darah mengalir melalui arteri jantung dan menentukan apakah terdapat penyumbatan atau penyempitan arteri.
11. **Pemeriksaan Endoskopi** adalah prosedur medis yang dilakukan untuk melihat organ tertentu, menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Prosedur ini memungkinkan dokter untuk mendeteksi gangguan atau masalah di dalam tubuh, sehingga dapat mengobatinya dengan tepat.
12. **Layanan pemeriksaan burn unit (luka bakar)** layanan penanganan luka bakar untuk pasien luka bakar anak dan dewasa.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 2
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 17 Nomor 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Nomor : HK.02.03/D.XIX/19903/2024 tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan RS Wahidin Sudirohusodo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

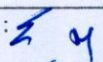
Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** akan merujuk pasien jaminan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang kepada **PIHAK KEDUA**, dimana **PIHAK KEDUA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**, serta berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Pemeriksaan yang dimaksud bertujuan untuk dan untuk kepentingan pasien yang dirawat sesuai indikasi medis, dan saling menguntungkan.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Rujukan untuk Pemeriksaan Penunjang seperti :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi;
 - d. Pemeriksaan Radiologi yang terdiri dari Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Radioterapi;
 - e. Pemeriksaan Angiografi Koroner;
 - f. Pemeriksaan Endoskopi;
 - g. Pemeriksaan Penunjang lainnya akibat alat rusak atau reagen habis atau pemeriksaan penunjang tersebut tidak tersedia di salah satu pihak maka PIHAK PERTAMA dapat merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA;
 - h. Pelayanan Burn Unit (pelayanan luka bakar).
2. Rujukan pasien jaminan yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan kepesertaan yang telah ditetapkan oleh pihak penjamin.
 3. Rujukan pasien jaminan yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain :
 - Nama pasien, jenis kelamin
 - Tanggal lahir
 - No.RM.
 - Asal rumah sakit.
 - Nama dokter penanggung jawab
 - Tanggal Rujukan
 - Jenis – jenis pemeriksaan.
 - Diagnosis dan keterangan klinis.
 4. Formulir rujukan telah disiapkan oleh pihak rumah sakit perujuk dan harus digunakan saat melakukan rujukan parsial dengan ketentuan formulir rujukan harus dibawa dan diisi lengkap saat peserta datang melakukan pemeriksaan.
 5. Khusus untuk peserta BPJS Kesehatan, rujukan dilengkapi dengan fotocopy Surat Eligibilitas Peserta (SEP).

BAB IV JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai tanggal **06-03-2025** sampai dengan **05-03-2028** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal perpanjangan kerjasama, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama oleh Tim Evaluasi masing-masing pihak
3. Apabila **PARA PIHAK** ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberitahukan satu

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

dengan yang lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

4. Apabila **PARA PIHAK** dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan belum memberikan informasi tentang perpanjangan atau pengakhiran kerjasama yang telah disepakati bersama, maka otomatis perjanjian kerjasama berakhir.

BAB V

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

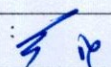
Pasal 6

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan keselamatan pasien dalam sistem rujukan parsial.
2. Evaluasi perpanjangan kontrak dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
3. **PARA PIHAK** sepakat indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul ini dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan kontrak sebagai berikut:
 - a. *Respon time* penyelesaian hasil Pemeriksaan Rujukan Parsial sesuai dengan batas waktu yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** seperti **terlampir**.
 - b. Pada kasus *cito/ emergency*, maka batas waktu penyelesaian hasil pemeriksaan cito sesuai batas waktu yang disepakati yang berlaku di kedua belah Pihak, seperti **terlampir**.
 - c. Kelengkapan pengisian form serah terima sampel atau pasien oleh **PARA PIHAK**.
 - d. Kepatuhan pelaporan insiden oleh **PARA PIHAK** dalam proses pelayanannya jika terjadi insiden.
 - e. Penyelesaian Komplain akibat keterlambatan hasil pemeriksaan harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maksimal 1x24 jam.
4. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan uji kalibrasi dan *quality control* terhadap alat Pemeriksaan Laboratorium, Radiodiagnostik dan pemeriksaan penunjang lainnya
5. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan dokumen bukti akreditasi laboratorium, Radiodiagnostik dan pemeriksaan penunjang lainnya sebagai penjaminan quality control atau bukti akreditasi dari intitusi **PIHAK KEDUA**.
6. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan SOP dan pedoman dalam melakukan pemeriksaan laboratorim, radiodiagnostik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelayanan pemeriksaan penunjang yang baik, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan identitas pasien secara lengkap dan sesuai dengan jenis pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan kepada PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan yang timbul, sesuai dengan jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan PIHAK KEDUA terhadap Pasien.
- b. Dalam hal PIHAK KEDUA menolak pemeriksaan penunjang pasien, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi via telpon atau chat Whatsab kepada contact person PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat, dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang dibuktikan hasil uji mutu.
- d. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh auditor bila diperlukan.
- e. PIHAK KEDUA bersedia menjamin sistem mutu laboratorium, sampel darah serta sistem mutu pelayanan radiologi dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi hal - hal yang menyebabkan tertundanya atau akan tertundanya penerbitan hasil pemeriksaan karena hal-hal sebagai berikut :
 - Aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik (UPS/Uninterrupted Power Supply) PIHAK KEDUA;
 - Kekosongan bahan foto reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
 - Bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "border line" atau "gray zone".
 - Alat mengalami kerusakan / gangguan.
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban menyertakan bukti-bukti pemeriksaan yang sesuai indikasi medis terhadap semua tagihan yang dikirim kepada PIHAK PERTAMA

3. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

pelayanan pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi dan angiografi koroner) ataupun standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 8

WAKTU PELAYANAN DAN CARA PENERIMAAN PASIEN

1. Prosedur Administrasi dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sebelum merujuk pasien ke PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menghubungi / menelepon PIHAK KEDUA melalui kontak person atau penanggungjawab harian yang ada di pasal 9 perjanjian ini, untuk memastikan ketersediaan pemeriksaan, kesiapan sarana dan waktu pemeriksaan penunjang agar disiapkan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA harus melengkapi berkas rujukan seperti :
 - Surat Pengantar Rujukan pemeriksaan pasien yang dirujuk kepada PIHAK KEDUA harus menggunakan formulir berupa permintaan pemeriksaan yang telah disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pemeriksaan (DPJP).
 - Surat Jaminan Rujukan yang menyatakan bahwa pasien yang dirujuk adalah benar pasien PIHAK PERTAMA
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Fotokopi Kartu BPJS pasien (jika pasien rujukan adalah pasien BPJS)
 - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) pasien (jika pasien rujukan adalah pasien BPJS).

Pasien PIHAK PERTAMA yang tidak memenuhi kriteria ayat 1 huruf b tersebut diatas, akan diberlakukan sebagai **PASIEN UMUM**.

2. Penerimaan Pasien pada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara :
 - a. Untuk pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik :

PIHAK PERTAMA wajib mengambil sampel darah pasien di tempat PIHAK PERTAMA dan dibawa kepada PIHAK KEDUA pada jam kerja sebagai berikut :

 - Senin s/d Jumat : Pukul 07.00 – 14.00 Wita di Laboratorium.

Untuk kasus emergency dilakukan di Laboratorium IGD :

 - Senin s/d Jumat : Pukul 14.00 – 08.00 Wita
 - Sabtu, Minggu/hari raya : 24 jam
 - b. Untuk pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
Jaringan tubuh pasien PIHAK PERTAMA yang hendak diperiksa di rumah sakit PIHAK KEDUA diantarkan oleh PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK KEDUA menerima permintaan pemeriksaan Patologi Anatomi dari PIHAK PERTAMA dengan waktu pelayanan:
 - Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 Wita
 - Jumat : Pukul 08.00 – 13.30 Wita
 - c. Untuk Pemeriksaan Radiologi

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasien PIHAK PERTAMA wajib datang ke rumah sakit PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menerima permintaan pemeriksaan radiologi dari PIHAK PERTAMA dengan waktu pelayanan :

- Senin s/d Jum'at : Pukul 08.00–16.00 Wita (untuk kasus non emergency)

- 24 jam setiap hari : Untuk kasus emergency masuk melalui Radiologi IGD

d. Untuk Pemeriksaan Radioterapi

Pasien PIHAK PERTAMA wajib datang ke rumah sakit PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menerima permintaan pemeriksaan radioterapi dari PIHAK PERTAMA dengan waktu pelayanan :

- Senin s/d Jum'at : Pukul 08.00–16.00 Wita (Jam kerja)

e. Untuk Pemeriksaan Angiografi Koroner.

Pasien PIHAK PERTAMA wajib datang ke rumah sakit PIHAK PENERIMA RUJUKAN, selanjutnya PIHAK KEDUA menerima permintaan pemeriksaan angiografi koroner dari PIHAK PERTAMA dengan waktu pelayanan :

- Senin s/d Jum'at : Pukul 08.00 - 16.00 Wita (untuk kasus non emergency)

- 24 jam setiap hari : Untuk kasus emergency masuk melalui IGD PJT

f. Untuk Pemeriksaan Endoscopy

Pasien PIHAK PERTAMA wajib datang ke rumah sakit PIHAK PENERIMA RUJUKAN melalui Polik Gastro, selanjutnya Dokter Polik Gastro PIHAK KEDUA memeriksa dan menentukan pemeriksaan endoscopy dari PIHAK PERTAMA dengan waktu

Senin s/d Jum'at : Pukul 08.00 - 15.00 Wita

g. Untuk pemeriksaan HIV / AIDS dan TB

Pasien PIHAK PERTAMA wajib datang ke rumah sakit PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menerima permintaan pemeriksaan pemeriksaan HIV dan TB dari PIHAK PERTAMA dengan waktu pelayanan :

Senin s/d Jum'at : Pukul 08.00–16.00 Wita

3. Petugas terkait PIHAK PERTAMA wajib menghubungi petugas terkait PIHAK KEDUA melalui contact person tersebut untuk menanyakan kesiapan sarana dan waktu pemeriksaan yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENANGGUNGJAWAB HARIAN

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA :

a. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik & Patologi Anatomi:

Nama : Andi Jusnaini Nur, Amd. Ak

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Nomor HP : 081271123348

b. Hasil Pemeriksaan Radiologi :

Nama : Nurwali Dain, Amd.Rad

Nomor HP : 085342249662

2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah :

a. Pemeriksaan Laboratorium :

Nama : dr. Darwati M, Sp.PK (K)

Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium

Nomor HP : 0895326645570

b. Pemeriksaan Patologi Anatomi :

Nama : dr. Amalia, Sp.PA., M.Kes.

Jabatan : Kepala Sub Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Nomor HP : 0811 442 183

c. Pemeriksaan Radiologi :

Nama : dr. Eny Sanre, Sp.Rad, M.Kes

Jabatan : Kepala Instalasi Radiologi dan Radioterapi

Nomor HP : 081318023798

d. Pemeriksaan Radioterapi

Nama : dr. Isnaniah, Sp.Onk.Rad

Jabatan : Kepala Sub Instalasi Pelayanan Radioterapi

Nomor HP : 081355 304 153

e. Pemeriksaan Angiografi Koroner :

Nama : Edy Jumadi, SKM, S.Kep, Ns., M.Adm.Kes

Jabatan : Kepala Sub Instalasi Tindakan Invasif
Jantung, Saraf dan Radio Invasif.

Nomor HP : 0852 5923 1513

f. Pemeriksaan Endoscopy :

Nama : Martinah Wahyuni, S.Kep., Ns

Jabatan : Kepala Sub Instalasi Poli dan Tindakan Sistem Pencernaan
(Gastroenterohepatologi)

Nomor HP : 0813 5506 8183

g. Pemeriksaan HIV/AIDS :

Nama : A. Tessioja, S.Kep.NS

Jabatan : PJ Poli Metadon HIV/AIDS

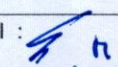
Nomor HP : 082188318529

h. Pemeriksaan TB Paru :

Nama : Sukri, AMK

Jabatan : Pojok Dofit

Nomor HP : 085240886367

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 10
JENIS PEMERIKSAAN

1. PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan pemeriksaan penunjang yang tidak terdapat di rumah sakit PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Laboratorium :

- i. Penanda Tumor :
 - AFP
 - PSA
 - Ca 125
 - CEA
 - Ca 129
 - β HCG
- ii. Tiroid :
 - FT 4
 - FT 3
 - TSHS
- iii. Anemia :
 - D.Dimer
 - Fibrinogen
 - Fe, TIBC
 - CD 4
 - Ferritin
- iv. HbsAg Konfirmasi
- v. Elektrolit, AGD
- vi. HbA1C
- vii. ALP, Gamma GT
- viii. Anti HcV, Rapid Tes HIV
- ix. ASTO
- x. C3 Komplemen
- xi. Kultur dan Sensitivitas Tes

b. Pemeriksaan Radiologi :

- i. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
- ii. CT-Scan Kepala.
- iii. Imaging Kontras Pembuluh Darah
- iv. Ultrasound Pembuluh Darah
- v. Imaging Payudara
- vi. Pemeriksaan dengan media Kontras

c. Pemeriksaan Angiografi Koroner :

- i. Echocardiography
- ii. Treadmill
- iii. Angiografi Koroner
- iv. CT-Scan Abdomen
- v. CT- Scan Toraks
- vi. DDR

d. Pemeriksaan Endoscopy

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- e. **Pemeriksaan Patologi Anatomi (PA)**
- f. **Pelayanan Radioterapi**
- g. **Pemeriksaan Patologi Klinik (Tidak ditanggung BPJS)**
 - i. HBsAg (Elisa)
 - ii. HBsAg (ICT)
 - iii. Anti HCV (Elisa)
 - iv. Anti HCV (ICT)
 - v. Anti HIV (Elisa Vidas)
 - vi. Anti HIV (ICT)
 - vii. HIV Viral Load (VL)
- h. **Pemeriksaan HIV/AIDS**
 - i. Rapid test 3 metode (reagens program)
 - ii. Test konfirmasi elisa
 - iii. Cd4
 - iv. Penanganan persalinan ibu yang HIV positif
 - v. Pengobatan antiretroviral (ARV)
 - vi. EID/RNA (reagen program)
- i. **Pemeriksaan TB Paru**
 - i. Sputum BTA 3 kali
 - ii. Gen Expert / TCM (reagen program)
 - iii. FNA
 - iv. MRI
 - v. TB Khusus Drug Injury
 - vi. TB-MDR

2. Apabila sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan akibat alat rusak atau reagens habis, atau pemeriksaan diluar yang diperjanjikan, maka PIHAK KEDUA dapat juga merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA lainnya.

Pasal 11 JAMINAN HASIL

1. PIHAK KEDUA akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA, untuk hasil pemeriksaan radiologi dengan melampirkan foto hasil pencitraannya.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dengan cara PIHAK PERTAMA mengambil hasil pemeriksaan segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan memberikan hasil pemeriksaan dalam amplop tertutup kepada PIHAK PERTAMA.
4. Apabila menurut PIHAK PERTAMA ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memeriksa kembali tanpa dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

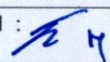
Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- a. Hasil meragukan yang dimaksud meliputi hasil yang tidak sesuai dengan diagnosa dokter pemeriksa atau ada alasan – alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- b. Hasil meragukan disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.
- c. Pengulangan pemeriksaan dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sampel yang sudah ada, atau sampel baru tergantung dari stabilitas sampel tersebut.
- d. Bagi pemeriksaan laboratorium yang kadarnya tidak stabil dalam darah karena tidak terpengaruh oleh metabolisme tubuh (tidak berkualitas dari hari ke hari) pemeriksaan tersebut dapat diulang selambat – lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil yang meragukan diperiksa dengan sampel yang baru.
- e. Bagi jenis pemeriksaan laboratorium yang kadarnya tidak stabil di dalam darah dan sangat tergantung kepada sistem metabolisme tubuh maka pemeriksaan dapat diulang selambat – lambatnya 24 jam setelah hasil yang meragukan diperiksa.
- f. Pada pemeriksaan ulang, kondisi / aktivitas pasien harus sama dengan kondisi / aktivitas pada saat pemeriksaan sebelumnya.

Pasal 12

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Jenis tarif pemeriksaan penunjang yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sesuai dengan tarif umum yang berlaku di PIHAK KEDUA.
2. Jika karena sesuatu dan lain hal PIHAK KEDUA harus melakukan perubahan tarif pemeriksaan penunjang, maka PIHAK KEDUA akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.
3. Perubahan tarif yang telah disepakati oleh PARA PIHAK ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
4. Jika karena sesuatu dan lain hal PIHAK KEDUA harus melakukan perubahan tarif pemeriksaan penunjang, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan tarif yang baru pada pemeriksaan penunjang setelah tarif tersebut diberlakukan.
5. Apabila terjadi perubahan pada tarif pemeriksaan penunjang, dimana pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada rekanannya, maka tarif yang dikenakan adalah tarif dari PIHAK KEDUA yang telah disesuaikan dengan tarif rekanan.
6. Apabila PIHAK PERTAMA tidak menyetujui perubahan tarif pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, dan antara PARA PIHAK tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, maka pelayanan pemeriksaan di luar rumah sakit PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 13
PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA akan mengirimkan perincian seluruh biaya pemeriksaan penunjang yang berlaku di PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara komulatif dengan melampirkan kwitansi serta rekapannya berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan.
2. Dokumen tagihan harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pengantar Tagihan 1 (satu) rangkap
 - b. Rekapitulasi tagihan pasien selama periode tertentu 1 (satu) rangkap.
 - c. Lembar Kwitansi / Bukti pembayaran bermaterai 1 (satu) rangkap.
 - d. Rincian biaya pemeriksaan (billing) asli 1 (satu) rangkap.
 - e. Lembar asli Surat Pengantar Rujukan dari PIHAK PERTAMA 1 (satu) rangkap.
 - f. Lembar asli Surat Jaminan Rujukan dari PIHAK PERTAMA 1 (satu) rangkap.
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien.
 - h. Fotokopi Kartu BPJS pasien untuk peserta BPJS Kesehatan.
 - i. Formulir Rujukan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit perujuk
 - j. Rekapitulasi jenis pemeriksaan.
 - k. Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk peserta BPJS-Kesehatan.
 - l. Biaya materai yang tercantum pada dokumen penagihan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA sanggup melakukan pembayaran seluruh biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan diterima lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
4. Apabila berkas sudah diterima lengkap maka akan dibayar secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan nomor rekening bank sebagai berikut :

PIHAK KEDUA sebagai PENERIMA RUJUKAN :

Nama : RPL 136 RSUP Wahidin Sudirohusodo
Bank : Bank Tabungan Negara Cabang RSUP Wahidin
No. Rekening : 00077-01-30-000010-3

5. Biaya administrasi bank ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
6. Apabila **PIHAK PERTAMA** lalai membayar tagihan sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yang ditentukan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya daftar pengajuan klaim serta bukti-bukti administrasi dan dianggap telah lengkap administrasi maka akan dilakukan denda sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari total tagihan.
7. Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender **PIHAK PERTAMA** belum dapat membayar tagihan dari **PIHAK KEDUA**, maka kerjasama pelayanan kesehatan untuk

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

sementara diberhentikan sampai adanya realisasi dari **PIHAK PERTAMA** dan pelayanan diberlakukan sebagai pasien umum.

8. Apabila **PIHAK PERTAMA** lalai membayar tagihan pelayanan kesehatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan berturut – turut, maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerjasama sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
2. Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat 1 (satu) di atas antara lain adalah wabah, peperangan (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), huru – hara, unjuk rasa, pemogokan umum, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya
4. Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
6. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
7. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 15

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sesuai Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara **PARA PIHAK** untuk memperpanjang perjanjian kerjasama

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya penetapan, ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
3. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
5. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
6. Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerjasama.
7. Dalam hal pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir, maka tunggakan dalam perjanjian ini yang belum terselesaikan harus segera diselesaikan dan tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16

KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi Bagian Hukum dan Humas **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 18
ADDENDUM / AMANDEMEN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau perjanjian dari waktu ke waktu.
2. Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatangiannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini, maka akan dibuat dalam bentuk Addendum / Amandemen yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu PERTAMAan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
3. Addendum / Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat secara tertulis dan dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 19
ALAMAT KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan / atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat – alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

- a. Bagian Marketing
Nama : Andi Dewi Sari
HP. : 085255125126
Email : rsoj.prb@gmail.com
- b. Bagian Admission
Nama : Rati Rufiyanti
HP. : 08114664702
Email : rsoj.prb@gmail.com
- c. Bagian Keuangan
Nama : Muhammad Hasib
HP. : 085222267885
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

2. PIHAK KEDUA :

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

1. Nama : drg. Andi Muhammad Chaeruddin, S.KG, M.Kes
Jabatan : Manager Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar
No. HP : 081340036640
Faksimile : 0411 – 592222
Email : humas.rswsmakassar@gmail.com
2. Nama : Aulia Yamin, SKM
Jabatan : Asisten Manager Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar
No. HP : 081242009392
Faksimile : 0411-592222
Email : humas.rswsmakassar@gmail.com

Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan

1. Nama : Nursuriyawati, SE
Jabatan : Manager Pelaksanaan Keuangan
No. HP : 082346561841
Email : finansial@rsupwahidin.com
2. Nama : Fatmawati, SE
Jabatan : Asisten Manager Perbendaharaan
No. HP : 082349610007
Email : finansial@rsupwahidin.com

Instalasi Verifikasi Penjaminan Pasien

1. Nama : dr. Ulfa Mutmainna
Jabatan : Kepala Instalasi Verifikasi Penjaminan Pasien
No. HP : 08114441247
Email : ippj_rsupsupwahidin@yahoo.com
No. Telp : (0411) 583333-584675 (Ext:8181), Fax (0411)587676

Pasal 20

KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan institusi yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban saling memberikan informasi secara resmi apabila di Instansi/Institusi **PARA PIHAK** terjadi perubahan pimpinan
3. Berita Acara tentang Perubahan Pimpinan yang bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dibuat oleh pihak yang mengalami perubahan Pimpinan disaksikan oleh pihak penjaminan atas Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
4. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

akan dituangkan kedalam suatu bentuk addendum yang merupakan bagian mengikatserta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

5. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara **PARA PIHAK** dan menggantikan semua perundingan, surat menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara **PARA PIHAK**, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah – masalah pokok dari perjanjian ini. Perjanjian kerjasama ini tetap berlaku, apabila Pihak yang bertanda tangan pada perjanjian kerjasama ini terjadi perubahan dan tidak lagi menduduki jabatan masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
6. Perubahan pimpinan disampaikan secara resmi oleh Pihak yang mengalami perubahan dengan melampirkan Berita Acara Perubahan.

Pasal 21

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Makassar, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, dilengkapi dengan materai cukup oleh masing-masing pihak dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya
Direktur


dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Direktur Utama


Prof. Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, Sp.An, KIC-KAKV